Diskussion 2219

Datum: 1940-05-22
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 5
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus (doi:10.5281/zenodo.18211787), byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Gustav Möller (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag har begärt ordet för att yttra mig något mera utförligt allenast beträffande en enda punkt. Enligt min uppfattning är utskottets förslag i dess helhet tillfredsställande, ja, jag höll på att säga i mycket hög grad tillfredsställande.

Den punkt, som jag sålunda skulle vilja säga några ord om, är den där Kungl. Maj:t avvikit från de sakkunnigas förslag, nämligen i fråga om styresmännens och sysslomännens inbördes kompetens. Naken behandlas i reservationen nr 3, som herr Hage också skrivit under. De övriga reservationerna tycker jag icke att det är värt att tala om, speciellt som det har ganska ringa betydelse, hur beslutet i de punkterna blir. Jag tror nog, att Kungl. Maj:t har rätt därvidlag. Skall man göra en sådan här sjukvårdsberedning skall man göra dess ställning så stark som möjligt.

TI fråga om den här punkten om sysslomännens ställning vill jag först understryka, att jag i princip har samma mening som reservanterna, nämligen att det i och för sig vore önskvärt att man kunde på ett rationellt sätt klyva läkarens och sysslomannens kompetensområden. Att jag för min del icke vågar tillstyrka de sakkunnigas förslag på den punkten beror alltså ingalunda på några principiella skäl utan helt enkelt därpå att jag funnit det svårt att föreställa mig, hur en sådan där klyvning skall kunna genomföras i praktiken. Jag har försökt att höra mig för hos sakkunniga personer och då icke minst anhängare av denna rationella klyvning av styresmannens och sysslomannens befälsrätt. Men på de frågor jag ställt har jag icke kunnat få något klart svar. Jag har till exempel ställt frågan: Vem skall ha befälsrätten över

husmodern? Skall **hon²** till hälften stå under lasarettsläkarens befäl och till den andra hälften under sysslomannen, eller hur skall det ordnas? Jag har som sagt för min del funnit, att personer, som äro speciellt sakkunniga på området och som själva haft, åtminstone delvis, ansvaret för skötseln av ett sjukhus, icke kunnat ge något klart svar på frågan.

Jag skall ta en annan punkt, som uppenbarligen rör en 1 eminent grad ekonomisk fråga. Jag tänker på mathållningen vid lasaretten. Det är självklart att kosthållet måste utgöra en av de allra största utgiftsposterna för ett lasarett. Med de sakkunnigas utgångspunkter skulle följaktligen frågan om ordnandet av denna angelägenhet falla under sysslomannens befälsrätt. Självfallet gör den så i fråga om inköp av varor och annat sådant. Den moderna

medicinska utvecklingen visar emellertid, att man icke bara i fråga om sådana patienter, som skola ha s. k. dietmat, utan överhuvud taget beträffande alla patienter tillmäter de näringsfysiologiska faktorerna en allt större och större betydelse. På den punkten har ju sysslomannen ingen som helst kompetens. Jag vet icke om alla landets lasarettsläkare för närvarande ha en tillfredsställande kompetens i dessa ting, men det är klart att utbildningen så småningom blir allt bättre och bättre även på detta område. Nu frågar jag mig: Skall spörsmålet om kosthållet höra till styresmannens kompetensområde eller till sysslomannens? Jag tror att jag skulle kunna nämna även andra punkter, där gränsdragningen ingalunda kan göras klar, och vid det förhållandet har jag fruktat, att man skulle råka ut för kompetenskonflikter mellan styresmännen och sysslomännen, som icke kunna bli till nytta för de lasarett där de inträffa. Den svagaste delen i Kungl. Maj:ts ståndpunkt är att styresmännen med sin ytterst grundliga läkarutbildning i regel icke ha någon ekonomisk utbildning. Jag erkänner utan vidare, att här är den svagaste punkten i det förslag, som jag tillrått Kungl. Maj:t att framlägga. Jag har emellertid ingalunda tillstyrkt förslaget i denna del därför att medicinalstyrelsen och läkarna önskat denna anordning utan därför att jag ansett, att det funnits starka sakskäl för denna ståndpunkt. Jag föreställer mig att det i praktiken kommer att gå till på det viset att läkarna, där de veta med sig att deras kompetens på det ekonomiska området är obetydlig, komma att överlåta skötseln av praktiskt taget alla sådana ärenden åt sysslomannen och icke lägga sig i dessa ärenden i någon nämnvärd grad. Jag vill visst icke påstå, att det ej förekommit undantagsfall, där man kanske överskattat sig själv, men i stort sett kommer det säkerligen att gå som jag antytt.

Nu konstatera reservanterna bland annat, att utvecklingen gått 1 den riktningen, att sysslomannen de facto fått mer och mer att säga till om på det speciella område av sjukhusets skötsel, som är hans. Detta är en utveckling, som jag hälsar med glädje, och jag förstår, att alla böra tycka, att det i och för sig blott är bra. Då frågar jag reservanterna: Om det nu pågår en sådan utveckling, som ingen opponerar sig mot, är det då nödvändigt att skriva in 1 sjukhusstadgan — som i och för sig alltid innebär en kanske onödig schematisering av saker och ting, som man önskar — att det gäller att stärka sysslomannens ställning? Jag tycker, att man kan låta denna utveckling få fortsätta i frihet utan att draga upp spörsmålet om vem som skall ha befälsrätten i vissa olika avseenden på ett sjukhus. Jag betraktar i alla fall den risk för svårigheter i fråga om sjukhusets skötsel, som uppstår, om man följer reservanterna och de sakkunniga, såsom större än risken av att låta utvecklingen så att säga följa sina egna linjer utan att precis fastslå den i en stadga. Jag är ganska säker på att där man har att göra med folk, som det är lätt att samarbeta med, är det tillstånd, som råder, i själva verket icke på något

sätt olämpligt eller odrägligt för någondera parten. Svårigheter komma alltid att uppstå, när det blir dualism i chefskapet; det tror jag mig lugnt våga försäkra. Jag har därför icke vågat mig på att medverka till att öka förutsättningarna för en sådan dualism, vilket självfallet icke hindrar, att i en sjukhusstadga det skall anges att i vissa frågor skall sysslomannen vara föredragande inför direktionen.

Jag tillåter mig för min del hoppas, att man även på denna punkt kommer att följa utskottet. Jag tror försiktigheten helt enkelt bjuder att i detta avseende följa utskottet och Kungl. Maj:t.

2. Ernst Hage (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag ber först att få tacka, därför att jag fattade statsrådets uttalande så, att det som man nu kommer att besluta, om man följer majoriteten i utskottet, innebär, att det kan bli en hållplats på vägen fram mot den anordning, som de sakkunniga tänkt sig.

I anledning av herr statsrådets anförande vill jag säga, att — även om det finns skäl för det påståendet, att det kan uppstå dualism mellan läkaren och sysslomannen på detta område, om bägge två ha anlag för att opponera sig — så har erfarenheten likväl många gånger visat, att finns det vilja till samarbete på bägge hållen, så ordnar sig den saken. Jag tror, att det är på det sättet i det verkliga livet. Dessutom vill jag säga, att det finns ju ännu en instans, som står över både läkaren och sysslomannen, och det är ordföranden i direktionen. Han är enligt mina begrepp den egentliga toppunkten i förvaltningen av ett lasarett. Jag tycker därför, att det är ganska naturligt, såsom det också här antytts, att då det finns olika meningar om huruvida läkaren eller sysslomannen skall behandla en viss fråga, har ordföranden i direktionen rätt att få avgöra den saken. Jag tror, att det till en början kunde ordnas så, när det gäller denna sak.

Beträffande frågan om kosthållet, som man här talat om, har naturligtvis läkaren i sin hand avgörandet över själva principfrågorna och vilken mat den och den patienten skall ha, medan själva inköpen och frågan, huru dessa skola ordnas, skola falla på sysslomannen.

3. Kerstin Hesselgren (Folkpartiet, woman)

Herr talman! Det var med stor tillfredsställelse som Jag hörde, att departementschefen var nöjd med utskottets uttalande. Detta är så mycket tacknämligare, som utskottet också i hög grad uppskattat det förslag, som blivit framlagt av Kungl. Maj:t. När Kungl. Maj:t förklarat sig nöjd med utskottet, betyder det naturligtvis också, att Kungl. Maj:t utan vidare godtar det uppskov på ett år med de nya bestämmelsernas ikraftträdande, som föreslagits, samt även den lilla ändring, som gäller de större sjukstugorna — en fråga, som förmodligen herr Fast kommer att ytterligare tala om.

Beträffande sedan herr Hages anförande har departementschefen själv tagit upp frågan om sysslomännen så pass grundligt, att jag torde kunna gå förbi dem. Jag skulle dock vilja understryka, att vad som för mig här varit avgörande har varit det förhållandet, att läkaren och sysslomannen arbeta inom en sluten anstalt, och att möjligheterna till uppkomsten av rivningar och svårigheter mellan olika personer inom en sådan anstalt under alla förhållanden äro rätt stora. Därför tror jag, att det måste vara någon bland de inom anstalten anställda, som har sista ordet. Herr Hage har flera gånger talat om samarbetets och den goda viljans betydelse, och jag kan icke förstå annat än att

När jag tänker på den halva husmodern, måste jag såsom **kvinna**[1] starkt yrka på att **hon**[2] får vara hel och i sin helhet ytterst stå under styresmannen.

Herr Hage hade en annan invändning, som departementschefen icke tog upp, men som jag skulle vilja säga några ord om, därför att den frågan var uppe förra året och även då behandlades av andra lagutskottet, nämligen frågan om rätt för en vid sjukhuset anställd att vara medlem av dess direktion. Jag kan mycket väl förstå, att det kan kännas orättvist, att en person, vilken såsom herr Hage säger är särskilt kompetent, på det sättet skall vara hindrad att komma in i direktionen. Det finns emellertid en viss risk, om man sätter in en av de anställda i direktionen, nämligen den att denne helt naturligt blir den, som får anses vara talesman för alla de andra anställda. Då är det bättre, om direktionen får avhandla olika ärenden med olika personalgrupper enligt förhandlingsrättslagen, än att man, såsom här sagts, har t. ex. sysslomannen eller portvakten såsom medlem i direktionen och denne då blir den, vilken kommer att föra allas talan. Det är bättre, att ekonomipersonalen kan få framföra sina åsikter, **sköterskorna**[3] sina åsikter o. s. v. Jag tror därför, att riksdagen gjorde alldeles rätt förra året, när den avslog de motioner, som då voro före. Jag har svårt att tänka mig, att riksdagen redan i år skall fatta ett annat beslut än det som fattades då — och detta så mycket mera som nu tillkommit den nya lagen om förhandlingsrätt, som vi förra gången hänvisade till och som ger möjlighet för olika personalgrupper att framföra sina åsikter.

Jag har emellertid själv reserverat mig i en fråga. Departementschefen har sagt, att han fäster sig mycket litet vid om det går 1 den ena eller andra riktningen, och därför kan jag för min del naturligtvis icke låta bli att hoppas, att beslutet går i den riktning, som jag vill. Det är mänskligt att resonera på det sättet. Vad jag i detta fall vill är en sak, som både medicinalstyrelsen och samtliga läkarorganisationer uttalat sig för, nämligen att det nuvarande systemet med tillsättande av underläkartjänster alltjämt skall vara kvar, d. v. s. att medicinalstyrelsen skall tillsätta underläkare och icke, såsom nu föreslås, sjukvårdsberedningen. Vad som är den svaga punkten i förslaget att sjukvårdsberedningen skall vara den som tillsätter underläkare är naturligtvis, att enhetligheten och objektiviteten lättare bevaras, om statens högsta medicinska myndighet avgör, huru underläkarna skola placeras. Vi skola komma ihåg, att dessa skola räkna tjänsteår, vilken beräkning för deras framtid blir av oerhört stor betydelse, och då är också deras anställning vid det ena eller andra sjukhuset av allra största betydelse. Jag tror, att det blir mera objektivitet i avgörandet, om medicinalstyrelsen får behålla sin nuvarande rätt. Det är emellertid en annan sak, som trasslar till det hela så, att jag tycker, den gamla metoden är betydligt enklare. Man har känt på sig, att den medicinska sakkunskapen måste finnas med, men eftersom man icke vill låta medicinalstyrelsen behålla avgörandet, har man i stället löst frågan på det sättet, att man inom varje län inrättat en nämnd av tre läkare. Därvidlag är jag ganska orolig, när det gäller objektiviteten. Först och främst lära tre så upptagna personer ha svårt att komma tillsammans och diskutera saken, och vidare få vi nu tjugufyra olika sakkunniga nämnder spridda över hela landet. Att då någon sorts likartad bedömning kan komma i fråga, förefaller mig åtminstone ganska svårt. Jag tror därför, att det vore lyckligt, om vi kunde behålla de be-

stämmelser, som nu finnas. Detta förutsätter emellertid, herr talman, en ändring i 16 $, som jag kommer att yrka på, när vi komma fram till denna paragraf. I analogi med detta ha reservanterna gått in för två andra frågor. Den ena gäller att tillsättande av tandläkare skall ske, såsom Kungl. Maj:t säger, efter samma system som tillsättande av underläkare. När vi sålunda i reservationen yrka på att medicinalstyrelsen alltjämt skall tillsätta underläkare för att man skall slippa den här tillsättningsnämnden, följer därav, att vi ha samma yrkande, när det gäller tandläkarna. Här har man visserligen enligt förslaget icke tänkt sig en särskild nämnd, som skulle vara förslagsställare, utan man har tänkt sig, att en enda person, nämligen tandläkareinspektören, skulle ha detta uppdrag, vilket väl ännu mindre borgar för likformigheten. Vi mena därför, att det vore rättvisare att även här gå efter det gamla systemet.

Den tredje reservationen sammanhänger också med frågan om tillsättandet av underläkartjänsterna. Jag håller mindre styvt på den än på frågan om själva tillsättandet men jag tycker, att den ändå hänger direkt ihop med de andra. Vi föreslå, att medicinalstyrelsen fortfarande skall vara den, som fastställer instruktionen för underläkarna och även för husmödrarna. Beträffande frågan om fastställande av instruktion för husmodern skulle jag vilja säga ett ord. Från sjuksköterskehåll har nämligen mycket starkt understrukits, att man inom sjuksköterskeorganisationerna under många år strävat efter att få husmoderns ställning vid sjukhusen något bättre befäst eller jag skulle vilja säga — mera likartad över hela landet. Själv har jag mycket underliga minnen av husmoderns ställning vid det sjukhus, där jag i min ungdom tjänstgjorde, nämligen Akademiska sjukhuset. Där hade husmodern egentligen ingenting annat att göra än att sitta och lappa linne. **Hon²** hade inte ett dugg med oss **sjuksk öterskor³** att skaffa, och vi hade icke den ringaste respekt för **henne²**, eftersom **hon²** inte direkt hade att bestämma över personalen. Nu har det så småningom ordnats så, att man fått en instruktion även för husmodern, i vilken ingå vissa kompetensföreskrifter o. s. v. **Sjuksköt erskorna³** mena, att det alltjämt bör vara medicinalstyrelsen, som fastställer instruktionen för husmodern likaväl som för läkaren-styresmannen. Dessa båda sista frågor, herr talman, återfinnas i betänkandet i form av yttranden, och jag kommer sålunda, när vi komma fram till motiveringen, att ha vissa förslag att framställa.

Jag skulle vilja sluta, såsom herr Hage, med att säga, att jag visserligen är mycket angelägen om att min reservation går igenom. Jag tror, att det vore klokt och praktiskt. Men jag måste å andra sidan erkänna, att det icke kan sänka värdet av vad man får genom Kungl. Maj:ts förslag, därest reservationen icke skulle gå igenom. Kungl. Maj:t har med sitt förslag verkligen ordnat upp saken på ett mycket praktiskt och förståndigt sätt. I mycket stor utsträckning är, om jag fattat rätt, förslaget ett godkännande av praxis, men det är en praxis, som icke funnits vid alla landsting, som man nu vill stadfästa för landet i dess helhet. Av den anledningen anser jag, att det är mycket önskvärt att förslaget går igenom. Jag vill således, herr talman, yrka bifall till Kungl. Maj:ts förslag med undantag av vad jag här sagt i fråga om min reservation.

4. Olof Nilsson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Vid 10 $ i sjukhuslagen har jag jämte några andra kammarledamöter föreslagit, att den bestämmelsen, som diskvalificerar vid ett sjukhus anställda för ledamotskap i direktionen, måtte utgå. Jag erkänner, att denna fråga i detta stora sammanhang icke har

så stor betydelse som sådan, och det föreföll mig också, när Jag lyssnade till utskottets vice ordförande, att **hon²** ansåg, att den icke ägde så pass betydelse, att det var nödvändigt att motivera, varför utskottet icke kunnat biträda motionärernas förslag, då samma fråga även väckts vid fjolårets riksdag, men då blivit avslagen. Anledningen till att jag ändå återkommer med detta SPpÖrsmål, är att jag anser, när nu sjukhuslagen står under revision, det nödvändigt, att riksdagen än en gång får pröva denna framställning.

Jag vill betona, att frågan för motionärerna i första rummet icke är en personalfråga, utan att vi betrakta den mera såsom ett spörsmål rörande en sjukhuspersonalens medborgerliga rätt i jämförelse med övrig 1 allmän tjänst anställd personal. Gå vi till de kommunalanställda, finns det ingen sådan diskvalifikation, intet förbud för den som arbetar i ett kommunalt företag att sitta i en verkstyrelse. I den valkrets, jag representerar, ha vi med framgång och med mycket goda erfarenheter använt den praxis att i de kommunala styrelserna sätta folk från personalen. Det är nämligen till nytta för styrelserna, att man på det sättet kan direkt från arbetsplatsen förmedla erfarenheterna till olika styrelser. Utskottet har gått fullständigt vid sidan av denna motivering och i stället inriktat sig på att diskutera frågan ur fackliga . synpunkter. Sjukhuspersonalen liksom den i allmän tjänst anställda personalen behöver numera icke gå en bakväg för att få sina fackliga intressen tillgodosedda. Våra fackliga organisationer äro så starka, att vi på den vägen kunna få våra intressen tillgodosedda. Det råder i stället den meningen inom dessa personalgrupper — kanske framför allt bland de i allmän tjänst anställda — att man här kan, om man vill, åstadkomma samverkan mellan anställda och arbetsgivare samt ömsesidigt utnyttja varandras intressen och erfarenheter och på det sättet främja företagets intressen. Detta är, skulle jag vilja säga, en form av industriell demokrati. Vissa grupper inom utskottet borde åtminstone icke stå alldeles främmande för det intresse, som rör sig inom arbetarnas led för detta spörsmål.

Herr Hage hade ett annat intressant spörsmål att peka på i detta sammanhang, som gäller sjukhuspersonalen. ZLåt oss säga, att en sjukhuspersonal kan ha inom sina leder någon med ett sådant allmänt förtroende, att han kommer in i landstinget. När en sådan person blivit invald till landstingsman och kommit in i landstinget, åtnjuter han icke så pass förtroende, att han kan bli vald såsom ledamot i egen sjukhusdirektion. Då upphör det allmänna förtroendet till honom men väl kan han få sitta i förvaltningsutskottet, i beredningsutskottet eller lönenämnden o. s. v. För att sitta i en sjukhusdirektion, som ofta kan vara en mycket liten anstalt, har han icke landstingets eller andra lagutskottets förtroende. Man kan väl ändå tycka, att det är orimligt att fasthålla vid detta förbud för sjukhuspersonal, och det kan icke hjälpas, att man frågar sig, om icke andra lagutskottet kunnat komma åtminstone med en mera vägande motivering för sin ståndpunkt än vad man lyckats åstadkomma i utlåtandet.

Andra lagutskottet av i fjol var åtminstone öppenhjärtligare och uppriktigare inför detta spörsmål, då det uttalade, att det vore anmärkningsvärt, att sjukhuspersonal icke kunde få representeras i en sjukhusdirektion, men så långt i uppriktighet och förståelse har icke det sammansatta utskottet kunnat sträcka sig. Jag kan icke underlåta att säga, att man får det intrycket, att landstinget och i detta fall de landstingsmän, som nu i egenskap av riksdagsmän deltagit i utskottets behandling av denna fråga, icke önskat ha sjukhuspersonalen alltför nära inpå sig i sin verksamhet. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den av herrar Norman och Hage avgivna reservationen.

5. Erik Fast (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Det har vitsordats från alla håll, att det föreliggande förslaget är godtagbart, men man har samtidigt sagt, att man naturligtvis önskar få sina speciella synpunkter tillgodosedda vid avgörandet. För egen del har jag på en och annan punkt haft en annan mening än den, som återfinnes i Kungl. Maj:ts proposition, men jag har å andra sidan måst säga mig, att det förslag, som i dag ligger på riksdagens bord till avgörande, om man ser det som en samlad bild, enligt mitt förmenande är det bästa möjliga, som det i nuvarande läge finns möjlighet att åstadkomma. Därför har jag också avstått från att avge reservation på någon punkt och ställer mig sålunda i dag solidarisk med utskottsutlåtandet i dess helhet, naturligtvis med mer eller mindre varma känslor på den ena och den andra punkten.

Inledningsvis vill jag ha sagt, att det bästa i den lagrevision, som nu föreligger, är att den bygger på den utveckling, som har ägt rum, och på de erfarenheter, som man under många år har kunnat göra ute i landstingens förvaltning. Man har tagit sikte på vad man genom utvecklingen kunnat uppnå utan några egentliga laga föreskrifter. När man på detta sätt tar sikte på att reglera ett förhållande, till vilket utvecklingen har lett fram, kan man också vara tämligen övertygad om att lagstiftningen befinner sig på mycket god och säker grund.

När jag har sagt detta, herr talman, vill jag på en punkt höja ett varnande finger till landstingen. När nu landstingslagen och sjukhuslagen ge förvaltningsutskotten all den rörelsefrihet, som är tänkbar — förvaltningsutskottet kan vara icke blott förvaltningsutskott utan även sjukvårdsberedning, hälsovårdsberedning och direktion för ett eller flera eller samtliga sjukhus i länet — så vill jag framhålla, att den omständigheten, att lagen ger en provkarta på vad som med hänsyn till särskilda omständigheter ute i länen är möjligt, givetvis icke innebär en inbjudan till förvaltningsutskotten att taga på sig en arbetsbörda, som kommer att överstiga deras förmåga. Jag uppskattar synnerligen högt de många personer, som ute i länen i egenskap av direktionsmedlemmar ha utfört en mycket förnämlig insats på sjukvårdens område. Jag tror, att vi alltjämt äro i behov av att kunna utnyttja deras sakkunskap, deras arbetslust och deras stora erfarenhet. Det är därför icke nödvändigt, att förvaltningsutskotten utnyttja alla de möjligheter till centralisering, som denna lag ger möjlighet till. Förvaltningsutskotten böra med klokt omdöme och med hänsyn till de säregna förhållanden, som kunna existera i det ena eller andra länet, gå fram med den varsamhet, som enligt mitt förmenande är nödvändig.

Det finns mycket annat, som kan anföras till motivering för vad jag nu anfört, men jag skulle därutöver endast vilja framhålla, att vi icke böra göra arbetsbördan för förvaltningsutskottet så tung, att man tvingas att välja ledamöter i detsamma enbart med hänsyn till att vederbörande i tillräcklig utsträckning förfogar över sin tid, ty i så fall får man icke samma kvalitet på de valda som om de kunna väljas ur något litet större utgångspunkter och med litet större rörelsefrihet. De möjligheter, som lagen erbjuder, tror jag som sagt icke komma att missbrukas utan komma att leda till att man får den smidighet i organisationen, som gör det möjligt att anpassa sig efter de säregna förhållanden, som kunna råda i de olika länen.

Sedan jag sagt detta skall jag, herr talman, be att få övergå till att med några ord beröra de reservationer, som åtfölja utskottsutlåtandet. Jag tar dem därvid i den ordning, som jag antecknat dem, även om detta kanske icke är den ordning, som borde följas med hänsyn till utlåtandets avfattning. Jag vill därvid börja med att säga några ord rörande den fråga, som herr Nilsson i

Göteborg nu senast vidrörde, d. v. s. frågan om att befattningshavare vid sjukhus skall äga rätt att väljas till ledamot och suppleant i direktionen.

Låt mig först konstatera, att denna fråga flera gånger varit under behandling i riksdagen och senast under fjolåret. Riksdagen har därvidlag intagit en ganska bestämd ståndpunkt och sagt, att den icke vill vara med om en sådan anordning. Då frågar jag: Har det inträffat något, som skulle ge anledning till att samma riksdag, som förut prövat saken, i år skulle intaga en annan ståndpunkt? Jag tror det icke. En enda sak har inträffat, men den går icke i den riktningen, att man kan använda det såsom skäl för en ändring. Jag syftar på förhandlingsordningens godtagande även för sjukvårdspersonalen. Frågan om det sätt, på vilket förhandlingar med personalen skola föras, är alltså nu ordnad. Härtill kommer, att sjukvårdspersonalen ju även är fackligt organiserad och att man icke blott för förhandlingar med de lokala myndigheterna utan att det även upptagits mera centrala förhandlingar mellan dessa personalgrupper och landstingsförbundet.

Man har emellertid i dag erkänt, vad man icke tidigare velat erkänna, nämligen att detta icke är något personalkrav. Det är icke någon fråga, som personalen såsom sådan fäster någon större vikt vid. Jag tackar för detta erkännande. TI så fall kunna vi diskutera denna sak från litet andra utgångspunkter än tidigare. Innerst inne undrar jag ändå, om det icke i alla fall är på det sättet, att man ser denna fråga som en personalfråga. Även om man icke skulle göra det, kommer det efter ett genomförande av denna ändring att i rätt hög grad bli en personalfråga. Man har frågat, varför man icke skall kunna välja den eller den utomordentligt skickliga karlen till ledamot av direktionen, bara därför att han råkar vara anställd vid sjukhuset. Ja, jag tror nu för min del icke, att vare sig herr Karlsson i Ystad eller herr Lindley i Söderhamn ha haft arbetskraft, som fått vara outnyttjad bara därför att de icke kunnat väljas in i en sjukhusdirektion. Jag tror, att man sannerligen utnyttjat deras arbetskraft till det yttersta på andra områden. Ingen duktig karl lär gå arbetslös, därför att han icke kunnat

inväljas i en sjukhusdirektion. Det finus så mycket att göra inom ett län, att jag tycker icke detta är något bärande skäl. Jag vet icke vilken uppfattning de två åberopade personerna skulle ha, men jag skulle tro, att förståndiga karlar som de voro båda två, så skulle de kanhända varit mindre tillfredsställda med att väljas in i en sjukhusdirektion. Det kan ju hända, att de skulle känt det, som om personalen på alldeles särskilt sätt på dem hade ställt krav, som de icke ställde på andra direktionsmedlemmar. Härmed är jag inne på den kärnpunkt, som frågan enligt mitt förmenande har.

Därest man vidtar denna förändring, så kommer detta att medföra konsekvenser på andra håll, som man då måste vara beredd att taga men som jag icke tror, att riksdagen är beredd att taga. Vidare är jag tämligen övertygad om, att om man gör denna ändring, kommer det att medföra, att man kommer att göra framställningar från personalgruppernas sida till de olika politiska grupperna inom direktionen o. s. v. att få en representant vald. Denne representant kommer i så fall i ett synnerligen svårt läge, därför att personalen betraktar honom såsom en representant för personalen, vilket han kanske själv icke vill vidkännas. Jag tror i allmänhet så gott om svenska folket, att vederbörande, han må tillhöra den ena eller andra gruppen i samhällslivet, försöker se opartiskt på de frågor, som skola behandlas i en sådan direktion.

För min del tror jag icke det finns något verkligt behov av denna ändring, ty det samarbete, som man behöver i en sjukhusdirektion, åstadkommes på helt annat sätt, genom samråd. Man tillkallar vissa personer, som man vet sitta

inne med speciell sakkunskap, och skaffar sig sålunda på det förberedande

stadiet nödiga informationer och upplysningar. Att anlita den utvägen tror

jag även i fortsättningen skall vara bäst både för sjukhusen och för perso-

I en annan reservation har man gjort gällande, att rätten att utse underläkare och att tillsätta distriktstandläkare i fortsättningen liksom förut skall vara förbehållen medicinalstyrelsen. Här har dock samtidigt erkänts, att detta i och för sig icke är någon stor fråga, men man har ansett, att detta vore det lämpligaste sättet. På denna punkt skall jag göra det erkännandet, att tillsättandet av sakkunnignämnd av läkare i de olika länen icke verkat tilltalande på mig. Jag tror, att det närmast innebär en överflödsgärning. Det är något, som man så att säga vill ge i ersättning för att man tagit ifrån medicinalstyrelsen denna uppgift och som skall trygga tillräcklig sakkunskap vid dessa frågors avgörande. Jag hyser emellertid den uppfattningen, och jag gör det på goda grunder, att sjukvårdsberedningarna komma att handha dessa frågor på ett så tillfredsställande sätt, att de risker, som reservanterna tro, att man här kan löpa, icke komma att göra sig påminta i verkligheten. Det är min bestämda uppfattning. Dessutom är det ju icke längre till Stockholm och medicinalstyrelsen än det varit förut, och i den mån man behöver få särskilda upplysningar o. dyl., är jag övertygad om att man alltjämt underhand i nödig utsträckning kommer att hänvända sig telefonledes eller skriftligen till

medicinalstyrelsen, så att man särskilt under övergångstiden får det indirekta samarbete till stånd på dessa punkter, som verkligen kan bli av nöden.

Jag tror således icke, att det finns tillräcklig anledning att gå ifrån propositionen på denna punkt. Den ståndpunkt, som härvidlag har intagits i propositionen, harmonierar nämligen med hela det system, på vilket man byggt upp detta förslag. Jag tror därför som sagt icke, att man skall göra några avvikelser.

Fröken² Hesselgren yttrade nyss om sin andra reservation, att **hon²** fäste mindre avseende vid den. Denna andra reservation gäller frågan, om det skall vara sjukvårdsberedningen eller medicinalstyrelsen, som skall utfärda instruktioner för läkare och husmoder. Jag tror, att det även på denna punkt finns goda skäl att följa propositionen. Det kan nämligen icke hjälpas, trots all den aktning som jag hyser för medicinalstyrelsen, att den kan komma att se det hela ur väl teoretiska synpunkter. Vid ett sjukhus kunna dock ibland råda sådana mera säregna förhållanden, till vilka det är nödvändigt att taga hänsyn, när man gör dessa instruktioner. Förhållandena äro icke lika ens vid de olika sjukvårdsinrättningarna inom ett och samma län. Ett sjukhus befinner sig 1 utveckling; ett annat har redan nått den utveckling, som det skall ha, o. s. v. Aven andra förhållanden tvingas man att taga hänsyn till, när man skall göra upp instruktionerna. Jag tror därför, att det är synnerligen lämpligt, att sjukvårdsberedningarna få detta uppdrag, och jag hyser för mitt vidkommande i ingen som helst fruktan för att man icke kommer att använda denna fullmakt på ett för sjukvården fullt tillfredsställande sätt.

Härefter återstår endast en reservation, vilken herr statsrådet och chefen för socialdepartementet själv har bemött. Jag vill dock för min del också säga ett par ord om denna reservation. Jag hyser också den meningen, att man gärna bör ge åt sysslomannen en så stark ställning som möjligt, men jag kan för min del verkligen icke se, hur detta skall vara möjligt med det förslag, som utarbetats av de sakkunniga. Tillåt mig säga, och jag har dock ganska rik erfarenhet på detta område, att där förhållandena äro tillfreds-

ställande och där det finns samarbetsvilja vid en sjukvårdsinrättning mellan styresmannen och sysslomannen, där ordnar sig allting ändå och man behöver icke egentligen någon lagstiftning. Vid andra sjukhus åter kan det råda strid mellan styresmannen och sysslomannen, och jag vet, att sådana sjukhus finnas. Om man för deras räkning inför en lagstiftning, som avser att dela upp kompetensförhållandena mellan dessa båda personer, men icke lyckas göra det utan lämnar hälften av arbetet oreglerat, så kommer man ju att på ett alldeles särskilt sätt inbjuda till kompetensstrider och fortsatta stridigheter mellan styresmannen och sysslomannen. Vad går detta ut över? Jo, det kommer att gå ut över sjukvården vid det sjukhuset. Låt oss emellertid framför allt komma ihåg, att sjukhuset är till för sjukvårdens skull och icke har något som helst självändamål.

Statsrådet har i sitt anförande till statsrådsprotokollet redogjort för en rad av frågor, som äro av den beskaffenhet, att de kunna hänföras till såväl styresmannens som sysslomannens

kompetensområde. För min del skulle jag vilja säga, att det knappast finns några frågor vid ett sjukhus, som äro så renodlade, att man kan säga, att det är uteslutande ekonomiska frågor, som i övrigt ingenting ha att göra med sjukvården. Departementschefen talade här om matfrågor. Jag skulle vilja tillägga personalfrågor. De äro oftast av den beskaffenhet, att de ha att göra med ekonomien men också i mycket hög grad med sjukvården. När det gäller frågor om inköp av ytterligare utrustning till ett sjukhus, är det intet tvivel om att det icke kan uppstå mycket starka slitningar mellan sysslomannen och styresmannen. Styresmannen kommer med förslag om ytterligare inköp av instrumentalier, men sysslomannen säger, att det är en ekonomisk fråga, som jag skall be att få handlägga och föredraga. Skall man därvidlag anlägga sparsamhetssynpunkter eller skall man anlägga de synpunkter, som styresmannan har, att inköpet behövs för att tillgodose sjukvårdens krav? På detta sätt skulle man kunna fortsätta genom alla de ärenden, som direktionen har att handlägga, och man skulle få se, att en sådan kompetensklyvning i själva verket icke är möjlig. För min del tror jag för övrigt, att det är nödvändigt att det vid varje företag finns en högste chef och icke två chefer inom samma kompetensområde.

Till detta vill jag anknyta ett par andra reflexioner, som kanske äro nödvändiga att göra. Jag skall villigt erkänna, att vi numera ha sjukhus, som nått sådan utveckling, att det helt enkelt icke är möjligt — man kan knappast begära det — att en läkare skall kunna offra tillräckligt med tid för att fullgöra styresmannauppdraget. Jag skulle vilja ifrågasätta, huruvida icke för dessa sjukhus utvecklingen numera nått därhän, att det vore lämpligt att undersöka, om icke en särskild styresman borde tillsättas. Det har sagts, och jag har själv sagt det vid ett sammanträde med läkare, att läkarna äro icke utbildade med hänsyn till en del av de uppgifter, som de för närvarande ha att handlägga som styresmän. Undan för undan skaffa de sig emellertid sådan utbildning. Jag vill emellertid i detta sammanhang fästa uppmärksamheten vid att i den pågående utredningen angående läkarutbildningen har man tagit sikte på denna fråga. Det torde icke råda något tvivel om att därest förhållandena medge det, varom vi i dag veta mycket litet, kommer man säkerligen att sörja för att fortbildningskurser anordnas för sådana läkare, som tänka att någon gång komma i den ställningen, att de kunna bli styresmän. Det kan också tänkas, att en läkare för att mottaga ett sådant uppdrag rent ut sagt skall vara tvungen att ha skaffat sig den nödiga utbildningen på detta område. Detta talar ju icke för att man i förtid skulle kunna göra denna boskillnad i fråga om kompetensområdet för sysslomän och läkare.

Jag vill vidare fästa uppmärksamheten på, att det nu föreliggande förslaget dock innehåller avsevärda förbättringar ur rent teknisk synpunkt. Förslaget bygger på den förutsättningen, att ordföranden i direktionen skall få bestämma, vilka ärenden han själv vill föredraga. Dessutom utgår man från såsom självklart, att renodlat medicinska ärenden skola föredragas av styresmannen och renodlat ekonomiska ärenden av sysslomannen. Det förutsättes vidare, att man skall kunna utse ett par ledamöter i direktionen, med vilka såväl styresmannen som sysslomannen ha att samråda. Förslaget bygger alltså på samarbetets princip, ehuru man hållit fast vid den gamla tanken på en enhetlig ledning för ett företag. Jag tror att detta förslag

kan garantera en lugn och god utveckling. Sedan är det möjligt, att denna utveckling kan leda till att förslag läggas fram, vilka nu icke ens äro påtänkta, men som måhända längre fram kunna visa sig ändamålsenliga.

Jag tillåter mig, herr talman, att yrka bifall till utskottets förslag icke endast vid den nu föredragna punkten utan till utskottets hemställan och motivering i dess helhet.